ANNEXE TECHNIQUE A AU CODE 16 — PROTOCOLE DE DÉMARRAGE SOCIAL

Version : V1.4

Annexe technique adoptée en application de l’article 19 du Code 3 et visée aux articles 1, alinéa 2, lettre h), 4 et 7, alinéa 5, du Code 16.

Art. 1 — Nature, fonction et effets

1. Le présent Protocole définit une méthodologie pour évaluer les étapes sociales liées au démarrage des Cercles pilotes, des Bassins et de la Fédération minimale. La méthodologie est utilisée pour vérifier les seuils sociaux institutionnels prévus à l’article 4 du Code 16.
2. Le Protocole ne constitue pas une source autonome d’obligations, de sanctions, d’exclusions ou de limitations individuelles. Sa non-application :
    a) ne constitue pas, en soi, une violation au sens du Code 4 ;
    b) n’entraîne pas de suspensions, de sanctions ou de préjudices individuels ;
    c) ne limite pas l’accès au Code 4, à la Garantie, aux biens vitaux ou au Panier 1-2.
3. La non-application documentée de la part du Cercle peut uniquement avoir pour effet que le seuil social institutionnel pertinent n’est pas franchi et, par conséquent, empêcher la proposition ou la délibération du passage de phase. Cet effet concerne le Cercle en tant qu’entité institutionnelle et n’entraîne pas de conséquences individuelles.
4. Aux fins du présent Protocole, le Conseil de référence pour le soin est :
    a) le Conseil Santé, jusqu’à l’activation du Conseil Soin ;
    b) le Conseil Soin, à compter de l’activation prévue par le Code 16, article 3, alinéa 3.
    Toute référence au Conseil de référence pour le soin s’entend conformément au présent alinéa.
5. La documentation est produite, dans la mesure du possible, sous forme agrégée et sans profilage, conformément au Code 7, article 2.2. Les données ne sont recueillies que dans la mesure nécessaire à la vérification du seuil pertinent. Le seuil minimal d’agrégation est défini par le Conseil Réseau lorsqu’il est actif, afin de réduire le risque d’identification directe ou indirecte, dans le respect de la séparation des domaines prévue par le Code 6, article 11.
6. Le Protocole ne se substitue pas aux compétences, aux procédures ou aux garanties prévues par les autres Codes et n’autorise pas le Conseil Transition ou d’autres organes à adopter des mesures individuelles non prévues par les normes applicables.

Art. 2 — Niveau 1 : confiance et démarrage du Cercle

Phase institutionnelle de référence : Phase 0 du Code 16, à titre indicatif de zéro à six mois.
Durée opérationnelle minimale : de zéro à quatre-vingt-dix jours.

1. Le Niveau 1 vise à vérifier la soutenabilité sociale initiale du Cercle pilote et à favoriser des conditions minimales de confiance et de collaboration.
2. Avant la délibération constitutive du Cercle pilote, trois rencontres non délibératives sont organisées. Chaque participant peut décrire ses motivations, sa disponibilité effective, ses limites personnelles et les éventuelles charges de soin pertinentes pour l’organisation. Les informations recueillies sont consignées au procès-verbal sous forme agrégée et non nominative. Pour le Cercle né d’un réseau en application de l’article 17 du Code 16, les rencontres ont lieu dans les quatre-vingt-dix jours suivant la conversion.
3. Une carte agrégée de la capacité de soin et d’organisation est établie ; elle peut prendre en compte :
    a) le temps disponible au total pour les activités du Cercle ;

b) la présence de charges de soin qui ont une incidence sur l’organisation ;

c) les besoins fonctionnels pertinents pour prévoir des activités accessibles ;

d) les indicateurs organisationnels de surcharge.

Le recueil ne constitue ni un diagnostic, ni une évaluation sanitaire individuelle, ni une classification des personnes. Les données sont agrégées et sans profilage, conservées pendant douze mois au plus sauf délai différent imposé par une norme supérieure, et accessibles exclusivement aux Conseils compétents pour les finalités prévues par le Protocole.

4. Le Cercle adopte un pacte organisationnel qui exclut le recours à des mineurs, à des personnes fragiles ou à des animaux de compagnie de proximité pour combler des carences organisationnelles, couvrir des tours de service incompatibles avec leur protection ou remplacer du personnel nécessaire.

5. Un moment symbolique et facultatif d’adhésion au Cercle pilote peut être prévu. Ce moment ne produit pas d’effets juridiques et ne constitue pas une condition de l’adhésion, de l’accès aux droits ou du bénéfice des services essentiels.

6. Le Conseil Transition rédige une attestation technique sur l’application du Niveau 1 et sur la soutenabilité sociale résultant des données agrégées. L’attestation contribue à la vérification du seuil F0 → F1 prévu par le Code 16, article 4, alinéa 1, lettre d).

Art. 3 — Niveau 2 : cohabitation et prévention de la surcharge

Phase institutionnelle de référence : Phase 1 du Code 16, à titre indicatif de six à dix-huit mois.
Durée opérationnelle minimale : de quatre-vingt-dix à cent quatre-vingts jours.

1. Le Niveau 2 vise à améliorer la cohabitation opérationnelle et à prévenir la surcharge de l’organisation et des personnes.

2. Une formation L1 sociale d’une durée totale de quatre heures est offerte gratuitement ; elle porte au moins sur :

   a) l’interruption sûre des activités à risque ;

   b) la reconnaissance et le signalement de la fatigue et de la surcharge ;

   c) les techniques de base de facilitation ;

   d) le principe de non-représailles.

   La formation est dispensée par des personnes ayant des compétences L2 ou L3 vérifiées conformément aux normes applicables.

3. Chaque Assemblée générale est conduite par deux facilitateurs, avec rotation obligatoire. Dans une même Assemblée, il n’est pas permis de cumuler la fonction de facilitateur avec celle d’auteur d’une proposition. Le procès-verbal indique les facilitateurs sans mentionner d’autres données non nécessaires.

4. Le dépassement de l’un des indicateurs suivants déclenche un tutorat organisationnel avec le Conseil de référence pour le soin :

   a) une moyenne supérieure à quinze heures hebdomadaires d’activité du Cercle, calculée sur une base trimestrielle selon une méthode agrégée définie par le Conseil compétent ;

   b) le dépassement des limites de pointe horaire prévues par le Code 1, article 6, alinéa 5.

   Le tutorat consiste en la vérification de l’organisation et, si nécessaire, en la proposition d’une redistribution des charges. Il ne constitue ni une sanction, ni une évaluation individuelle négative, ni une limitation de droits.

5. La mesure prévue à l’alinéa 4 est effectuée selon des critères agrégés et ne peut pas être utilisée pour classer les personnes ou leur attribuer des évaluations individuelles. Les canaux de signalement personnel prévus par les Codes applicables demeurent disponibles.

6. Une procédure de réparation sociale peut être engagée, exclusivement sur une base volontaire, avec une personne de confiance extérieure au Cercle, choisie d’un commun accord. La procédure :

a) est volontaire pour toutes les personnes concernées ;

b) n’est pas une condition de l’accès au Code 4 ;

c) ne retarde ni ne remplace un signalement en application de l’article 5 du Code 4 ;

d) ne retarde ni ne remplace le recours prévu à l’article 17 du Code 3.

7. Un registre exclusivement agrégé et sans profilage des signaux organisationnels de surcharge peut être tenu. Le registre est conservé pendant douze mois et peut être consulté par le Conseil de référence pour le soin et par le Conseil Transition exclusivement pour leurs fonctions respectives, dans le respect de la séparation des domaines prévue par le Code 6, article 11.

8. La documentation agrégée sur l’application du Niveau 2 contribue à la vérification du seuil F1 → F2 prévu par le Code 16, article 4, alinéa 2, lettre e).

Art. 4 — Niveau 3 : autonomie sociale et sécurité ressentie

Phase institutionnelle de référence : Phase 2 du Code 16 et, par la suite, maintien en Phase 3.

1. Le Niveau 3 vise à prévenir la concentration relationnelle et décisionnelle, l’endogamie organisationnelle et les conditions susceptibles de compromettre la sécurité ressentie.

2. Dans chaque Conseil, il ne peut y avoir simultanément plus de deux personnes appartenant au même noyau de cohabitation stable. Les informations nécessaires pour vérifier cette limite sont traitées de manière confidentielle et limitées à la finalité de composition des Conseils.

3. La rotation des Conseils Transition suit l’article 4.4 de la Constitution et l’article 5, alinéa 3, du Code 16. S’appliquent la limite de quatre-vingt-dix jours consécutifs, la limite totale de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante-cinq jours et l’intervalle d’au moins douze mois d’activité exclusivement en CBO ordinaire entre deux mandats, dans les limites prévues par les normes citées.

4. Chaque Cercle pilote organise au moins un échange inter-Bassins, qui comprend la participation volontaire d’au moins une personne pendant une semaine continue dans un autre Bassin, pour des activités de contribution. Les dépenses directement nécessaires sont couvertes par la Caisse commune selon les règles applicables. Le suivi de l’échange est agrégé et sans profilage.

5. Tous les six mois, un questionnaire anonyme sur la sécurité ressentie est réalisé, selon des modalités techniques propres à empêcher l’identification des personnes. La question minimale est : « Te sens-tu en sécurité ici ? ». Les réponses ne sont pas publiées lorsque le nombre de participants ne permet pas une agrégation adéquate. Le questionnaire est réalisé et dépouillé dans chaque Cercle pilote ; le seuil de l’alinéa 6 est vérifié pour chacun d’eux et le plan correctif concerne le Cercle dans lequel il est dépassé.

6. Si plus de vingt pour cent des réponses valables sont négatives :

   a) la proposition de passage à la phase suivante reste suspendue jusqu’à l’élaboration et à la vérification d’une mesure corrective ;

   b) le Conseil de référence pour le soin élabore, dans un délai de trente jours, un plan portant sur l’organisation et la structure du Cercle ;

   c) le plan est suivi d’une nouvelle vérification dans un délai de soixante jours.

   Le dépassement du seuil ne constitue pas, en soi, un motif de sanction, d’exclusion ou de mesure individuelle.

7. Un point de non-retour au sens du Code 16, article 1, alinéa 2, lettre g), ne peut pas être proposé sur la seule base de l’évaluation des membres internes au Bassin concerné. L’avis obligatoire et non contraignant d’au moins une personne L3 extérieure, tirée au sort selon la procédure du Code 4, est requis.

8. La documentation agrégée sur l’application du Niveau 3 contribue à la vérification du seuil F2 → F3 prévu par le Code 16, article 4, alinéa 3, lettre f), et à la vérification du maintien du seuil F3 → F4 prévu par l’alinéa 4, lettre d), du même article.

Art. 5 — Documentation, vérification et mise à jour

1. La documentation de chaque niveau est rédigée sous forme agrégée et sans profilage conformément au Code 7, article 2.2. Elle est conservée pendant trente-six mois, sauf délai différent prévu par une norme supérieure, et rendue accessible conformément à l’article 15 du Code 3, dans le respect de la protection des données et de la séparation des domaines.

2. L’application du Protocole est vérifiée par le Conseil Transition, après avis obligatoire du Conseil de référence pour le soin.

3. Un avis négatif du Conseil de référence pour le soin peut suspendre uniquement la proposition institutionnelle de passage de phase jusqu’à l’élaboration et à la vérification de l’éventuel plan correctif. Il ne peut pas entraîner de suspensions, d’exclusions, de sanctions ou de limitations individuelles et n’affecte pas l’accès au Code 4, à la Garantie, aux biens vitaux ou au Panier 1-2.

4. Le résultat de la vérification est transmis aux organes compétents conformément à l’article 4 du Code 16. Le présent Protocole n’attribue pas au Conseil Transition le pouvoir de délibérer de manière autonome le passage de phase.

5. Le Protocole peut être mis à jour sur proposition du Conseil Transition ou du Conseil de référence pour le soin, conformément à l’article 19 du Code 3, après publication pendant au moins soixante-douze heures. Le Conseil Transition ne peut pas le modifier de manière autonome ni modifier les seuils fixés par le Code 16.

6. Aucune disposition du présent Protocole :

    a) n’introduit de compétences permanentes ;

    b) ne modifie les seuils du Code 16 ;

    c) n’introduit d’obligations individuelles autonomes ;

    d) ne limite les droits ou les garanties prévus par les Codes applicables ;

    e) ne remplace les avis contraignants prévus par la réglementation de référence.

7. **Liens normatifs :** Code 16, articles 1, 4, 5, 7 et 8 ; Code 3, articles 3, 4, 13–17 et 19 ; Code 4 ; Code 6, article 11 ; Code 7, article 2.2 ; Code 12 ; Constitution, article 4.